

La reforma que EsSalud necesita del próximo gobierno (2026–2031)

Gobierno y liderazgo, cierre de brechas con enfoque del asegurado y acciones rápidas dentro del ordenamiento jurídico. Modelo GEMSES.

Resumen ejecutivo

EsSalud sostiene la salud de **12.76 millones de peruanos** —cerca de un tercio del país— y se financia casi por completo con el aporte del 9 % que hace cada trabajador formal a través de su empleador. **No recibe recursos del presupuesto público**: es el seguro que el trabajador se paga a sí mismo. Y sin embargo, quien aporta cada mes es hoy quien menos garantías tiene de ser atendido a tiempo.

La institución no está quebrada por falta de dinero: cerró 2025 con superávit operativo (ingresos S/ 17,774 M, +10.4 %) y grado de inversión (Fitch BBB). Está enferma de **inestabilidad de gobierno**: cerca de diez presidentes ejecutivos entre 2021 y 2025. La buena noticia para el próximo gobierno es que **21 de 22 acciones de reforma se pueden ejecutar sin ley del Congreso**.

“La reforma de fondo es despolitizar la dirección, ponerle indicadores públicos y devolverle la institución al asegurado que la financia.”

La crisis, en cifras oficiales

Indicador	Valor
Población asegurada	12,761,781 (set-2025); 14.2 M al 2030
Concentración en Lima + Callao	~45 %
Presidentes ejecutivos 2021–2025	~9–10 (uno cada ~5 meses)
Espera quirúrgica > 45 días	66.1 % (2025); meta 43 % al 2030
Diferimiento de citas	25.9 días (10.4 en 2019)
Camas operativas perdidas	–3,988 (dic-2023 a oct-2025)
Equipamiento crítico operativo	40.5 % (23,842 de 58,907)
Tomógrafos inoperativos	17 de 63 (27 %)
EESS en local no propio	59.5 % (235 de 393)
Brecha de inversión al 2035	> S/ 31,000 millones

Fuentes: PEI EsSalud 2026-2030; Diagnóstico MTPE nov-2025; ComexPerú 2025; Libro Blanco EsSalud/Banco Mundial.

Gobierno y liderazgo: el nudo de todo

El dato más elocuente no es clínico, es político: cerca de diez presidentes ejecutivos entre 2021 y 2025. EsSalud es un organismo público adscrito al Ministerio de Trabajo (MTPE), con autonomía de gestión (Ley 27056). Su órgano de gobierno es el **Consejo Directivo tripartito de 9 miembros** (art. 5): 3 del Estado, 3 de los empleadores y 3 de los asegurados. El asegurado y el pensionista ya tienen tres asientos por ley; el problema es que durante largos periodos están vacíos y solo funciona la Presidencia Ejecutiva, que el Ejecutivo nombra y remueve a discreción. Esa designación discrecional es la raíz de la puerta giratoria.

La palanca política clave: el Ejecutivo puede, **sin pasar por el Congreso**, sentar a los nueve consejeros, exigir perfil técnico por reglamento y endurecer el buen gobierno corporativo. Solo blindar el mandato del Presidente Ejecutivo exige ley (ya hay dictamen en el Congreso).

La reforma piso por piso: IAFAS · Redes · IPRESS

Cuando el que cobra la prima y el que da el servicio son la misma persona y nadie le rinde cuentas a nadie, se pierde la tensión sana que obliga a mejorar. El asegurado paga su 9 % y no tiene forma de reclamarle al fondo por un servicio que el propio fondo se autoevalúa. La reforma consiste en poner a conversar —y a exigirse— a estos tres niveles, con reglas claras entre ellos.

Nivel 1 — IAFAS: gobernar el fondo del asegurado

La función aseguradora debería **comprar salud a nombre del asegurado**; hoy solo transfiere presupuesto histórico sin exigir resultados. Qué cambiar: separar aseguramiento de prestación (*purchaser-provider split*); compra estratégica por resultados; sostenibilidad con estudios actuariales públicos; plan de beneficios explícito y exigible. Indicadores: % de gasto por compra estratégica (KPI), agotamiento del fondo (KRI), cumplimiento del plan de beneficios (KCI). Estándar JCI–GLD.

Nivel 2 — Redes Prestacionales: la bisagra que hoy se traba

30 redes ordenan el territorio y manejan la referencia y contrarreferencia; ahí se rompe la continuidad. Qué cambiar: fortalecer el primer nivel; referencia con tiempos máximos garantizados; gestión territorial con metas y presupuesto por resultados; distribuir la capacidad ociosa. Indicadores: % resuelto en primer nivel (KPI), referencias vencidas (KRI), contrarreferencias cerradas (KCI). Estándar JCI–ACC.

Nivel 3 — IPRESS: donde el asegurado toca el sistema

408 establecimientos propios: aquí se juegan la lista de espera, el medicamento y el trato. Qué cambiar: plan de choque contra listas de espera; cadena de suministro por proceso; seguridad y calidad publicadas; acreditación tipo JCI; cuidar al personal; el reclamo como termómetro. Indicadores: espera quirúrgica y satisfacción (KPI), infecciones y eventos adversos (KRI), reclamos resueltos en plazo (KCI). Estándar JCI–IPSG/QPS/PCI/MMU/SQE.

La reforma funciona cuando el circuito se cierra: la IAFAS compra resultados, las Redes los articulan y las IPRESS los producen —y los tres publican lo que logran—.

Radiodiagnóstico descentralizado y financiamiento

Hay 63 tomógrafos y 17 están parados (27 %). La salida no es comprar más equipos que se malogran, sino descentralizar el diagnóstico: tercerización (pago por estudio), telerradiología vía CENATE, leasing/renting con disponibilidad garantizada y módulos desmontables —todo sin ley del Congreso—.

EsSalud se financia con el 9 % del trabajo formal y no recibe presupuesto público; su sostenibilidad depende de la formalidad del empleo. Por eso **defender el empleo formal es defender EsSalud**, y cada cola eliminada (telesalud, farmacia vecina, “Hospital te llama”, intercambio prestacional) es plata del aportante que rinde. Eso es *flow management*.

Las 22 acciones rápidas (por instrumento legal)

21 de 22 acciones no requieren ley del Congreso. Se ejecutan por Resolución Suprema, Decreto Supremo, Acuerdo del Consejo Directivo, Resolución de Presidencia Ejecutiva o directiva interna.

#	Acción	Instrumento	Plazo
1	Sentar el Consejo Directivo completo (los 9)	Sin ley · R. Suprema+R.M.	100 días
2	Perfil técnico e incompatibilidades para consejeros	Sin ley · Decreto Supremo	1 año
3	Endurecer el Código de Buen Gobierno Corporativo	Sin ley · Acuerdo de Consejo	1 año
4	Presidente Ejecutivo elegido por el Consejo, mandato fijo	REQUIERE LEY	+1 año
5	Tablero público en vivo (esperas, camas, stock)	Sin ley · Resolución PE	100 días
6	Defensor del Asegurado con respuesta en 72 h	Sin ley · Resolución PE	100 días

#	Acción	Instrumento	Plazo
7	Control concurrente de la Contraloría en compras	Sin ley · Resolución PE	100 días
8	Supervisión reforzada con SUSALUD	Sin ley · Convenio	1 año
9	Jornadas quirúrgicas de noche y fin de semana	Sin ley · Acuerdo de Consejo	100 días
10	Intercambio prestacional (operar donde haya cupo)	Sin ley · Acuerdo/Resolución	100 días
11	Telesalud y telemonitoreo de crónicos	Sin ley · Directiva (CENATE)	100 días
12	Farmacia Vecina + delivery + aviso de medicina	Sin ley · Directiva	100 días
13	Compra corporativa y subasta inversa de medicamentos	Sin ley · Resolución PE	1 año
14	Red descentralizada de radiodiagnóstico (pago por estudio)	Sin ley · Resolución PE	100 días
15	Telerradiología nacional vía CENATE	Sin ley · Directiva	100 días
16	Equipos por leasing/renting con disponibilidad	Sin ley · Resolución PE	6–12 m
17	Módulos desmontables de imágenes	Sin ley · Resolución PE	3–9 m
18	“Cero Colas”: cita digital + atención preferente	Sin ley · Directiva	100 días
19	“Hospital te llama”: el hospital agenda tu cita	Sin ley · Directiva	100 días
20	Gestor de caso del paciente crónico	Sin ley · Directiva	1 año
21	Carta de Derechos visible (español/quechua/aymara)	Sin ley · Directiva	100 días
22	Trato digno al personal de salud	Sin ley · Resolución PE	100 días

Hoja de ruta 2026–2031

- **Primeros 100 días — Parar la hemorragia:** sentar a los 9 consejeros; tablero público; Defensor 72 h; “Cero Colas”; jornadas quirúrgicas de noche y fin de semana; telesalud y telerradiología; control concurrente de la Contraloría. Sin una sola ley nueva.
- **Año 1 — Medir la verdad y descongestionar:** línea base pública de esperas, camas y stock; intercambio prestacional; compra corporativa de medicamentos; red descentralizada de imágenes; endurecer el buen gobierno corporativo.
- **Años 2–3 — Cerrar lo que más duele:** reducir a la mitad la espera quirúrgica y de citas en especialidades críticas; fortalecer el primer nivel; reposición de equipos por renting con disponibilidad garantizada.
- **Años 3–4 — Institucionalizar la calidad:** ruta de acreditación tipo JCI; compra estratégica por resultados; estudio actuarial público y defensa de la base cotizante.
- **Año 5 — Blindar la reforma:** aprobar en el Congreso que el Presidente Ejecutivo sea elegido por el Consejo con mandato fijo; indicadores públicos normalizados. El éxito se mide en una pregunta: ¿el asegurado espera menos y confía más que en 2026?

Fuentes

Diagnóstico Situacional de EsSalud (MTPE, 21-nov-2025); PEI EsSalud 2026-2030; RENIPRESS-SUSALUD 2026; Libro Blanco EsSalud/Banco Mundial (2019); informe OIT de gobernanza (2023); ComexPerú (2025). Marco legal: Ley 27056 y DS 002-99-TR; Ley 26790; Ley 29344 (AUS); DL 1302/1466; Ley 30421; Ley 30024; Ley 32069; Ley 29230/32460; Ley 27806; Leyes 28683/29414/30490; Ley 27785. Modelo GEMSES (Pérez Pérez, 2021).